

寝ながら暴れるのは病気？ パーキンソンの前触れかも

レム睡眠行動障害 (RBD)

こんな“夜”はありませんか？



夜中に大声で叫ぶ



隣を殴る・蹴る



ベッドから飛び出す



鮮明で不快な夢

本人は朝になると覚えていないことも多く、気づくのは隣で眠る家族

それが「レム睡眠行動障害」



略称 RBD。夢を体がそのまま行動化してしまう睡眠の病気



前半夜(深い眠り)

後半夜＝レム睡眠が多い→出やすい



普通はなぜ夢で動かない？



ロックON=動かない

レム睡眠中は筋肉の力が
抜ける(筋アトニア=体のロック)



ロックOFF=動きすぎ

RBDはこのロックが外れ、
夢が行動になる

！ 金縛りは"逆"。ロックが目覚めに持ち越されて動けなくなる現象

中高年の男性に多い

約**1%**弱



一般人口の有病率

睡眠検査で確定した例

約**8割**



が男性

国際研究 82.5%

約**66**歳



平均年齢

中高年に多い



珍しすぎる病気ではなく、誰の身近にも起こりうる頻度

12年で約7割超

—— 年率およそ6% ——

1,280人を追跡した国際研究で、パーキンソン病やレビー小体型認知症などへ移行



※「必ずなる」ではありません

リスクが高い = 運動や記憶の症状より早く気づける貴重なサイン

なぜ睡眠が先に壊れる？



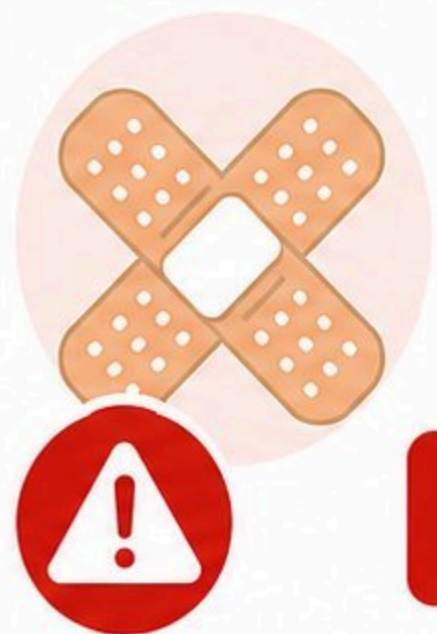
α -シヌクレインという異常なたんぱく質が、
運動や記憶を司る前に、睡眠を調節する脳の部分に先に現れることがある



怖い話ではなく、早く気づけるサイン



実は危険 — ケガにつながる



55%

約半数が受傷

睡眠中の行動でケガを経験



9人に1人

重大なケガ

医療を要する／硬膜下血腫の報告も



同床者がケガをすることも。たまにしか起きなくても受傷しうる



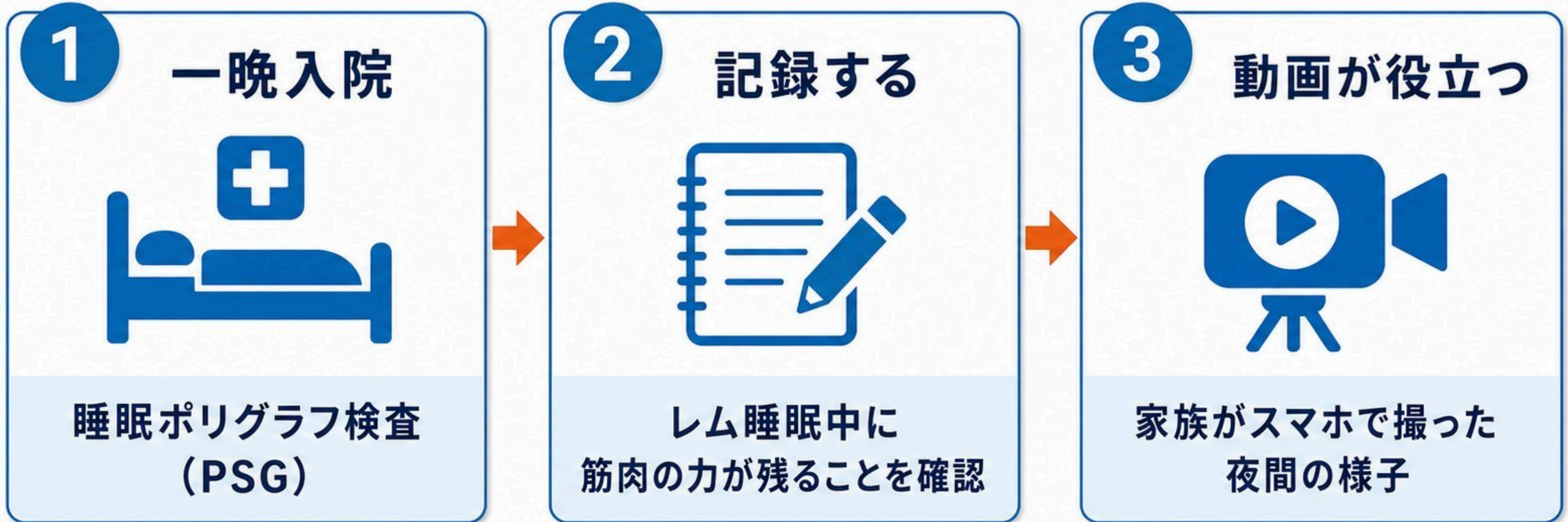
頻度が低くても早めの相談が大切

夢遊病との見分け方

見分けポイント	RBD	夢遊病・夜驚症(ノンレム)
 出やすい時間帯	 後半夜(明け方近く)	 前半夜(眠り始め)
 夢の記憶	 鮮明に覚えている	 乏しい
 多い年代	 中高年の男性	 子ども・若い人

 このほか、いびきを伴う睡眠時無呼吸や夜間てんかんとの見分けも必要

一晩の睡眠検査でわかる



問診や質問紙だけでは確定できない

今夜からできる安全対策

最優先の対策



枕元の刃物・固い物を片づける



家具の角にパッドを当てる



ベッド脇に柔らかいマットを敷く



症状が強ければ別室で寝る



受診を待たずに、今夜から始められます

治療と受診先



睡眠外来（第一）



併走



脳神経内科

睡眠検査ができる施設が第一。前触れの側面を脳神経内科が見る



約 **2/3** が治療に反応

メラトニン・クロナゼパムで多くが改善



近くに睡眠外来がなければ、まずかかりつけ医に相談

まとめ — 気づけたことは前向き

- ① 夢を体がそのまま行動してしまう睡眠の病気
- ② 中高年男性に多く、前触れになりうる（必ずではない）
- ③ 寝室を安全に＋睡眠外来／脳神経内科へ

✓ 気づけたことは、むしろ前向きな一歩



医知創造ラボ



チャンネル登録・高評価をお願いします